

Evaluación del Desarrollo y Tamizajes (EEDP, TEPSI)

1. Introducción y relevancia clínica

El **seguimiento del desarrollo infantil** es un eje esencial de la atención pediátrica integral. No basta con que el niño crezca adecuadamente en peso y talla: debe también adquirir habilidades motoras, cognitivas, comunicativas y sociales acorde a su edad.

La **evaluación del desarrollo psicomotor (DSM)** permite identificar alteraciones tempranas, implementar estrategias de estimulación oportuna y prevenir discapacidades permanentes.

En Chile, el **MINSAL** establece que todos los niños deben tener una **evaluación del DSM en cada control del niño sano**, utilizando instrumentos estandarizados:

- **EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor)**: para niños de 0 a 24 meses.
- **TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor)**: para niños de 2 a 5 años.

Ambos forman parte del **Programa Nacional de Infancia y Control del Niño Sano**, y su uso es obligatorio en la atención primaria.

En el **EUNACOM**, este tema se aborda con frecuencia mediante preguntas que evalúan:

- El uso adecuado de estas escalas.
- Su interpretación e indicaciones de derivación.
- La distinción entre retraso global, riesgo o desarrollo normal.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Concepto de desarrollo y evaluación

El **desarrollo psicomotor** refleja la maduración progresiva del sistema nervioso central (SNC) y la interacción del niño con su entorno.

La **evaluación del desarrollo** tiene por objetivo identificar **variaciones o retrasos** respecto del patrón normal esperado, mediante la observación directa, la entrevista con los padres y el uso de pruebas estandarizadas.

2.2. Propósito de la evaluación

1. **Detectar tempranamente desviaciones del desarrollo.**
2. **Distinguir entre retraso transitorio y patología estructural.**
3. **Orientar intervenciones de estimulación o rehabilitación.**
4. **Educar a los padres sobre el desarrollo normal.**
5. **Derivar oportunamente a especialistas.**

2.3. Principios de la evaluación del desarrollo

- El desarrollo es **secuencial, continuo y acumulativo**.
- Se evalúa en **cuatro áreas**: motora gruesa, motora fina, lenguaje y social.
- Se considera la **edad corregida** en prematuros (hasta los 2 años).
- La evaluación debe realizarse **en ambiente tranquilo y con confianza** entre niño y examinador.
- Los resultados siempre deben interpretarse junto al juicio clínico.

3. Clínica: instrumentos de evaluación del desarrollo

3.1. Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP)

Origen y propósito:

Creada en Chile por Rodríguez y cols. (1978), la EEDP fue diseñada para medir el desarrollo de niños **entre 0 y 24 meses de edad**. Es una herramienta validada y ampliamente utilizada en la red pública.

Áreas que evalúa:

1. **Motora**: control postural y desplazamientos.

2. **Coordinación:** motricidad fina, coordinación ojo–mano.
3. **Lenguaje:** comprensión y emisión de sonidos y palabras.
4. **Social:** interacción, juego e imitación.

Metodología:

Se aplican ítems de dificultad progresiva, observando si el niño logra o no la conducta.

El resultado se expresa como **Cociente de Desarrollo (CD)**:

$$CD = \frac{\text{Edad de desarrollo}}{\text{Edad cronológica}} \times 100$$

Interpretación:

- **Normal:** 85–115%
- **Riesgo:** 70–84%
- **Retraso:** <70%

Comentario EUNACOM:

Pregunta clásica:

“¿Qué instrumento evalúa el desarrollo psicomotor en un niño de 18 meses?”

✓ Respuesta: **EEDP**.

“¿Qué resultado indica retraso?”

✓ CD <70%.

3.2. Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI)

Origen y propósito:

Desarrollado por Haeussler y Marchant (1985, Chile), el **TEPSI** se utiliza en niños **entre 2 y 5 años**. Es el instrumento oficial del MINSAL para la evaluación del desarrollo en esa edad.

Áreas evaluadas:

1. **Coordinación:** motricidad fina y visomotora.
2. **Lenguaje:** comprensión y expresión verbal.
3. **Motricidad:** equilibrio, desplazamientos y movimientos gruesos.

Metodología:

Consta de **52 ítems** que el niño realiza en presencia del examinador.

Se otorgan puntajes parciales en cada área y un puntaje total.

Interpretación (según puntaje global):

- **Normal:** desarrollo acorde a la edad.
- **Riesgo:** leve retraso o lentitud en la adquisición de habilidades.
- **Retraso:** desempeño significativamente inferior al esperado.

El TEPSI no diagnostica patologías neurológicas, pero permite **tamizar a niños con riesgo** y derivarlos para evaluación especializada.

Comentario EUNACOM:

Pregunta típica:

“¿Qué test se utiliza para evaluar el desarrollo psicomotor en un niño de 3 años?”

✓ Respuesta: **TEPSI**.

“¿Cuáles son sus áreas de evaluación?”

✓ Coordinación, lenguaje y motricidad.

3.3. Otros instrumentos complementarios

Aunque la EEDP y TEPSI son los instrumentos oficiales en Chile, existen otros ampliamente usados:

- **Escala de Denver II:** instrumento internacional de tamizaje (0–6 años).
- **Ages and Stages Questionnaires (ASQ-3):** cuestionario aplicado a padres (tamizaje global).
- **Bayley Scales of Infant Development (BSID-III):** prueba diagnóstica más detallada (no de tamizaje).

Estas herramientas pueden complementar el diagnóstico en centros especializados.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de retraso o alteración del desarrollo **no se basa en exámenes de laboratorio**, sino en la **evaluación clínica y los resultados de las escalas**.

Sin embargo, si el niño presenta retrasos significativos o signos neurológicos, se deben solicitar estudios orientadores según la sospecha:

- **Evaluación auditiva y visual.**
- **Exámenes metabólicos o genéticos (si dismorfias o historia familiar).**
- **Neuroimagen (TAC o RM cerebral)** en casos de sospecha de lesión estructural.
- **Electroencefalograma (EEG)** si hay convulsiones o sospecha de epilepsia.

Criterios diagnósticos de alarma (MINSAL 2023):

1. Retraso mayor a 2 meses respecto de los hitos esperados.
 2. Retraso en dos o más áreas del desarrollo.
 3. Pérdida de habilidades previamente adquiridas.
 4. Puntuación en EEDP <70% o en TEPSI “retraso”.
 5. Falta de respuesta a estimulación o intervención inicial.
-

5. Tratamiento y manejo

El manejo depende del tipo y magnitud del retraso.

No existe tratamiento farmacológico: el abordaje se basa en **estimulación precoz, rehabilitación y educación familiar**.

5.1. En desarrollo normal

- Reforzar estimulación cotidiana: juego, lectura, canto, exploración.
- Controles regulares según calendario MINSAL.

5.2. En riesgo o retraso leve

- Ingreso al **Programa de Estimulación Temprana (Chile Crece Contigo)**.

- Educación a padres sobre actividades en el hogar.
- Reevaluar en 3–6 meses.

5.3. En retraso moderado o severo

- Derivación a **neurología infantil y equipo de rehabilitación (fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional)**.
- Evaluar audición y visión.
- Evaluar causas genéticas, metabólicas o estructurales.
- Seguimiento continuo por equipo multidisciplinario.

Comentario EUNACOM:

El manejo correcto ante un niño de 18 meses con EEDP 80% (riesgo) es **estimulación temprana y control en 3 meses**, no derivar de inmediato al especialista.

6. Complicaciones

Si no se detecta y aborda a tiempo, un retraso del desarrollo puede derivar en:

- Retraso global permanente.
 - Trastornos del lenguaje o del aprendizaje.
 - Discapacidad intelectual.
 - Trastorno del espectro autista no diagnosticado.
 - Problemas de conducta o integración escolar.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. **EEDP:** 0–24 meses; **TEPSI:** 2–5 años.

2. Ambas son **herramientas de tamizaje**, no diagnósticas.
3. **CD <70% (EEDP)** indica retraso; **70–84%** indica riesgo.
4. **La pérdida de un hito adquirido** siempre requiere evaluación neurológica.
5. El **control del desarrollo** es obligatorio en cada control del niño sano.
6. En **EUNACOM**, las preguntas se centran en la edad de aplicación y la interpretación del puntaje.

Errores comunes:

- Interpretar la EEDP o TEPSI como pruebas diagnósticas definitivas.
 - No considerar edad corregida en prematuros.
 - Omitir derivación ante retraso en dos áreas.
 - Asumir retraso sin observar conducta directa del niño.
 - No incluir a los padres en el proceso de estimulación.
-

8. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **evaluación del desarrollo** permite detectar desviaciones tempranas del neurodesarrollo.
2. Las pruebas oficiales en Chile son **EEDP (0–2 años)** y **TEPSI (2–5 años)**.
3. Un **CD <70% o TEPSI “retraso”** indica alteración del desarrollo.
4. El manejo inicial es la **estimulación temprana**, con control en 3–6 meses.
5. La **derivación especializada** se reserva para retrasos persistentes o globales.
6. En **EUNACOM**, este tema aparece con preguntas sobre edad de aplicación, interpretación y conducta ante riesgo o retraso.